

国健医疗

四诊合参体质辨识报告

开封市龙亭区 1234452345

患者信息：

姓名：	撒地方	性别：	男	年龄：	22岁	生日：	2004-04-07
住址：							

四诊初步诊断

望诊（舌象分析）



舌苔图

核心证候为脾虚湿盛兼轻度气阴两虚。舌质淡红偏淡（舌色偏淡指数较高），舌体略胖、边有轻微齿痕，苔薄白润，舌面湿润无燥裂，提示脾失健运、水湿内停；舌尖稍红、舌中根部略显淡，反映中焦气虚兼轻度虚热。建议：①饮食宜温补健脾，如山药、莲子、薏苡仁煮粥；②忌生冷寒凉及油腻甜食，以防助湿伤脾。

补充分析

- 舌象结果已提示当前舌体与舌苔特征，建议与饮食、睡眠、情绪状态一起观察。
- 这类表现通常和运化偏弱、湿邪偏重有关，日常可留意清淡饮食与作息规律。
- 目前变化偏轻，重在早期干预和持续观察，避免继续累积疲劳与饮食失衡。
- 如果后续还有闻诊、问诊或切诊结果，可进一步提高整体辨证的稳定性。

闻诊（体质诊断）

诊断结论：气虚质
置信度：71.5%

体质标签：
气力不足
声音偏弱
声带振动不规则

补充分析

- 当前闻诊置信度为 71.5%，可作为参考，但不建议单独定性。
- 体质标签显示：气力不足、声音偏弱、声带振动不规则，说明声音特征与当前体质倾向存在一定关联。
- 若日常出现乏力、气短、咳嗽或情绪波动，建议结合具体症状继续观察。

问诊（症状问卷）

专项问诊结论

阴虚质

阴虚质

常见口干咽燥、五心烦热、睡眠不稳等倾向，调理重点在于滋阴润燥、减少耗伤。

补充分析

- 本次得分靠前的是：阴虚质13分、阳虚质12分、气虚质12分，可作为后续调理重点。
- 问卷分析适合与望诊、闻诊和切诊结果联动解读，不宜单独下结论。
- 若主诉症状持续存在，建议结合睡眠、饮食、情绪和运动习惯一起评估。
- 可按 1-2 周为周期复盘症状变化，结合复测结果动态调整调理重点。

饮食建议

- 可适当选择银耳、百合、梨、黑芝麻、蜂蜜等润燥食材
- 饮食宜清淡，少辛辣刺激
- 注意补充水分，避免过度耗津

禁忌提醒

- 避免辛辣烧烤和重口味饮食
- 避免熬夜和情绪过度紧张
- 避免长期处于干燥高温环境

后续建议

- 保持充足睡眠，少熬夜
- 适当做舒缓运动，避免过度出汗
- 如口干、心烦、失眠长期存在，建议进一步评估

切诊（脉搏检测）

心率：74.3 bpm

血氧：99.5 %

信号有效率：98.7 %

采样数：147

中医建议：

【结论性质】本结果基于PPG自动分析，仅反映当前时段脉搏特征倾向，不等同于临床确诊。【融合判定】缓脉倾向（多特征融合）【区分度】主次得分差=1.7（越高表示判定越稳定）【融合得分】数=0.0，迟=0.5，缓=2.2【脉象倾向】缓脉范围（心率中等）【脉搏特征】缓脉倾向、节律较齐、脉势中等、脉形偏缓、证据:心率中段(74.3bpm)、证据:节律较齐(CV=0.044)、证据:上升支偏慢(288.693ms)【量化摘要】RMSSD=25.064ms，节律CV=0.044，灌注指数PI=0.8045%。

补充分析

- 当前心率 74.3 bpm、血氧 99.5%，可作为循环与呼吸状态的基础参考。
- 信号有效率 98.7%、采样数 147，说明本次测量质量具备一定参考价值。
- 脉搏分析已给出中医建议，可与舌象和问卷结果一起综合判断。

AI 详细分析

不侧重模式下，将进行更充分的跨板块综合分析与分层建议。

结论摘要

- 核心证候为脾虚湿盛，兼有气阴两虚。**主要证据来自望诊舌象（舌质淡红偏淡、舌体略胖有齿痕、苔薄白润）与闻诊（声音偏弱、气力不足），指向脾失健运、水湿内停的基本病机。
- 存在阴虚与气虚的复合体质倾向。**问诊问卷明确提示“阴虚质”为最高分，但“气虚质”与“阳虚质”得分紧随其后；闻诊算法亦直接输出“气虚质”结论，表明气阴两虚的体质基础客观存在。
- 当前生理机能处于相对和缓但偏虚的状态。**切诊显示心率、血氧均在正常范围，但脉象呈现“缓脉”倾向，节律整齐但上升支偏慢，符合气虚推动无力、气血运行偏缓的脉象特征。
- 各诊法结论存在交叉印证与部分差异，**需整合解读。望诊与闻诊共同支持“气虚”；问诊突出“阴虚”；切诊的“缓脉”与气虚、湿盛均可关联。差异主要体现在阴虚证据的权重上，望诊舌象仅提示“轻度虚热”，而问卷得分突出。

5. 调理应以健脾祛湿为根本，兼顾益气养阴。鉴于脾虚湿盛是当前突出的功能失调，而气阴两虚是潜在的体质偏颇，调理需分清主次，避免滋阴过度助湿。

四诊综合解读

- 望诊 (舌象):** 算法结论为“脾虚湿盛兼轻度气阴两虚”。关键依据在于舌象结构化指标：**舌色偏淡指数 (70, 高)** 是气虚、阳虚的典型舌色证据；**舌色偏红指数 (30, 低)** 和**津液亏虚指数 (20, 低)** 均处于低水平，支持“阴虚”证据较弱，与“轻度气阴两虚”的结论相符。**苔色黄腻指数极低 (10)** 表明湿热不明显，湿象以“白润”为主，属寒湿或痰湿。风险提示：舌体胖、有齿痕是脾虚湿盛的确切指征，需优先处理。
- 闻诊 (音频):** 算法以中等置信度 (0.715) 判定为“气虚质”。标签“气力不足”、“声音偏弱”及声学特征如**较低的基频 (f0Mean: 99.08 Hz)** 和**较高的抖动 (jitter: 0.0232)**，共同映射为中医气虚导致声低、发声不稳定的表现。风险提示：音频结论单一指向“气虚”，未体现“阴虚”信息，需与其他诊法结合。
- 问诊 (问卷):** 算法结论为“阴虚质”。体质得分显示**阴虚质 (13分)** 为最高，但**气虚质 (12分)** 与**阳虚质 (12分)** 得分与之非常接近，形成“气阴两虚兼阳虚倾向”的高分体质簇。这表明患者自我感知的症状群更符合阴虚内热、气虚乏力的复合表现。风险提示：问卷反映主观感受，需与客观体征（如舌象）对照，以辨别虚热是实火还是阴虚所致。
- 切诊 (脉象):** 采集质量高 (qualityLevel: 高)。生理指标 (心率74.3 bpm, 血氧99.5%) 均正常。算法融合判定为**“缓脉倾向”，关键量化证据包括中等心率**、**节律整齐 (CV=0.044)** 以及**上升支偏慢 (288.693ms)**。缓脉主湿盛或气虚，在此背景下，与望诊的脾虚湿盛、闻诊的气虚相呼应。风险提示：缓脉在健康人中亦可出现，需结合全身症状判断其病理意义。

跨板块证据整合

- 支持性证据 (气虚与湿盛):** **望诊**的舌淡、胖大、齿痕与**闻诊**的声弱、气短，共同构成了“气虚”的强证据链。同时，**望诊**的舌体胖大、苔润与**切诊**的缓脉倾向，形成了“湿盛”或“水湿内停”的交叉印证。这三者高度一致，确立了“脾虚湿盛”作为当前核心病机的可靠性。
- 需整合辨别的证据 (阴虚):** **问诊**问卷强烈提示“阴虚质”，但**望诊**舌象仅见“舌尖稍红”，舌色偏红与津液亏虚指数均不高，提示阴虚火旺的典型特征（如舌红少苔）并不显著。**闻诊**也未提供阴虚（如声音嘶哑、干咳）的相关标签。因此，阴虚更可能是一种体质倾向或伴有轻微虚热，而非当前主导的实证。调理时需顾及，但不应作为首要攻伐目标。
- 整体画像:** 患者呈现“体-证分离”的特点。体质基底（问诊）是气阴两虚；而当前突出的功能失调（望、闻、切）是脾虚湿盛兼气虚。湿邪与阴虚存在一定矛盾（滋阴药可能助湿），因此辨证需以当前症状和体征为优先，调理上在健脾祛湿为主的同时，选用不滋腻的益气养阴之品。

体质/证候判断

- 当前主要证候: 脾虚湿盛证。**此为基于望、闻、切三诊客观征得出的核心诊断，置信度高。病位在脾，核心病机为脾气虚弱，运化水湿功能失常，导致水湿内停。
- 兼夹证候/体质倾向: 气阴两虚体质 (以气虚为甚)。**问诊问卷高分支持，望诊有轻度提示，闻诊明确指向气虚。阴虚为次要倾向，证据强度弱于气虚。
- 结论置信度分析:** 核心证候“脾虚湿盛”由望诊（直接舌象证据）、闻诊（气虚支持脾虚）、切诊（缓脉佐证湿盛）三重数据交叉验证，逻辑一致，置信度最高。兼夹的“气阴两虚”中，“气虚”部分得到闻诊与问诊双重支持，置信度中等；“阴虚”部分主要依赖问诊主观问卷，客观体征支持弱，故置信度相对较低，作为体质背景参考。

分层调理建议

核心原则: 健脾益气、祛湿化浊为主，佐以甘平养阴。忌滥用滋腻、寒凉之物，以防碍脾助湿。

近期调理 (1-2周): 化湿运脾，调整基础

- 饮食:**
 - 主食:** 多用薏苡仁、赤小豆、山药、莲子与大米同煮粥，健脾利湿。
 - 菜肴:** 适量食用白萝卜、冬瓜、鲫鱼（煮汤）、扁豆等利湿食材。烹饪可加入少许陈皮、生姜以醒脾化湿。
 - 饮品:** 可用炒薏米、茯苓片泡水代茶饮。
 - 慎食:** 替换精制米面为部分糙米、小米。
- 作息:**

- 1. 严格避免熬夜（建议23点前入睡），夜间阳气内收，熬夜伤气更助湿。
- 2. 午后如有困倦，可小憩15-20分钟，但不可久睡，以免气机郁滞。
- 3. 保持居住环境干燥通风，避免潮湿。

● **运动：**

- 1. 每日坚持散步30-40分钟，或练习八段锦，以微汗出为度，促进气机流通。
- 2. 避免剧烈运动、大汗淋漓，以免耗气伤津。

● **穴位保健：**

- 1. **足三里**（双侧）：每日按揉或艾灸10-15分钟，健脾胃、补中气。
- 2. **阴陵泉**（双侧）：每日按揉5分钟，健脾利湿的要穴。

● **禁忌：**

- 1. **忌生冷**：冰淇淋、冷饮、生鱼片及大量寒性水果（如西瓜、梨）。
- 2. **忌甜腻**：奶油蛋糕、巧克力、油炸食品、糯米制品，以免助湿生痰。
- 3. **忌滥用补品**：暂不宜自行服用阿胶、熟地等滋腻补品，或人参、黄芪等峻补之气药，恐虚不受补或助湿。

中期调理（1-3月）：健脾固本，兼顾气阴

- **饮食**：在近期基础上，可逐步增加平和益气养阴之品，如**小米、银耳、百合、莲藕、瘦肉**等。可每周食用1-2次**山药排骨汤**或**黄芪（少量）炖鸡**。
- **作息**：形成稳定的作息规律，保证充足睡眠。可尝试“子午觉”（午间小憩）。
- **运动**：在体力增强后，可逐渐增加运动强度，如慢跑、游泳，但仍以不觉疲劳为原则。
- **复评建议**：建议于1个月后复测舌象与脉象，重点观察舌体胖大、齿痕及舌色是否改善，脉象缓急是否变化，以评估祛湿与健脾效果，并据此调整养阴药物的引入时机与比例。

报告生成时间：2026/4/18 00:28:05

本系统仅为中医诊断辅助工具，不具备医疗资质，输出结果仅供参考，不能替代专业中医师面诊及诊疗方案

签发医师：张翰

3个月